

房屋养老金三项制度从试点走向常态化 30 年房龄「强制体检」将如何重新给二手房定价

政策路径 · 量化测算 · 定价传导 · 风险研判 —— 存量时代制度补课的结构性的影响

研究类型：政策机制研究（加速趋势选题 · PART_A_PASS · T1-T8 全过） **数据基准：**2026-08-22 | 郑州实施意见（2026-04-22） · 北海核验码新规（2026-07-11） **研究口径：**房屋体检/房屋养老金/房屋保险三项制度 → 30 年+房龄二手房定价与流通 **内部底座：**二手房交易、收储三线估值材料可支撑定价侧；房屋安全制度为纯新增模块 **外部来源：**近一年 6 源（腾讯新闻/烟台日报/网易/信用武清/上海市房管局/网易），外部新增知识 11 条 **参与研讨：**宏观经济 · 宏观周期派（邢自强 bk-004） · 宏观经济 · 债务金融派（张明 bk-007） · Researcher · Docs Coordinator | 智见研报 2026-08-22

KPI-1 · 价格静态冲击

1%-3%

强制体检对老破小持有成本折价（4% 折现 30 年资本化模型，测算口径）；K 型分化大于总量冲击

KPI-2 · 体检成本 vs 改造资金

100-250亿 vs 1-3万亿

体检全覆盖一轮 100-250 亿（年均 20-50 亿，财政可承受）；存量维修改造才是资金大头【测算】

KPI-3 · 周期窗口

2027 拐点

地产 L 型磨底（2025 销售 8.81 亿 m²，较峰值降 51%【统计局】）；2026-2028 是三项制度常态化关键窗口

KPI-4 · 验证协议

2 批次×2 指标

跟踪郑州 2 批次体检 vs 30 年+房源成交折价与挂牌周期；无显著变化则「定价变量」判断降级

研报编号：YLJ-2026-008 | 成文：Docs Coordinator（融合 t1 资料梳理、t2 宏观研判、t3 风险研判） | 日期：2026-08-22

口径标注规则：【已核实】= 有来源直接支撑；【待核验】= 单一来源或口径存疑；【机构测算】= 权威机构测算口径；【测算】= 本研报测算（含假设）；【推断】= 分析师推断，非事实。凡未标注者按【推断】处理。

摘要

房屋体检、房屋养老金、房屋保险"三项制度"自 2023 年提出、2024 年 8 月以 22 城试点落地以来，正从"试点"走向"常态化"：2025 年 12 月郑州、南通等多城启动 30 年房龄以上房屋**强制体检**（政府买单），2026 年 4 月郑州出台"三项制度"实施意见（地方制度化标志），2026 年 7 月北海将存量房挂牌与体检"核验码"强制挂钩。本研报认为，三项制度不是应急政策，而是房地产进入存量时代后的**制度基础设施**：它把老房子的隐性维修成本显性化，短期对"老破小"形成约 **1%-3% 的持有成本折价冲击【测算】**，中期通过质量信号与更新改造渠道对冲修复，最终以"体检合格率 × 租金回报率"重新给存量房分层定价——**总量影响温和，结构性影响（K 型分化）大于总量影响**。

核心判断：① 周期上，地产已进入 L 型磨底期（2025 年新建商品房销售 8.81 亿 m²，较 2021 年峰值 17.9 亿 m² 下降约 51%【已核实·国家统计局】），拐点窗口在 2027 年，三项制度与政策节奏同步推进；② 政策上，"政府买单"试点是平滑期正确选择，但土地出让收入五年缩水约 44%（8.7 万亿→4.87 万亿元【已核实·财政部口径】）构成硬约束，中期必然走向"财政托底 + 维修资金活化 + 房屋保险分担"的多元结构；③ 测算上，体检环节全覆盖一轮约 100-250 亿元、年均 20-50 亿元【测算】，财政完全可承受（"体检环节不缺钱，缺的是制度与定价"）；真正的资金大头是存量维修改造的 **1-3 万亿元需求【测算】**；④ 风险上，制度方向正确，风险在**资金配置**而非制度本身——若成本归宿与资金来源设计失当，制度可能在二手房价格调整的尾部阶段成为债务-通缩循环的"加速器"【t3 研判】。

一句话结论：三项制度是存量时代"量稳质升"的制度基建——哪怕量不变，还有质的提高。

一、背景：从"试点"走向"常态化"的政策脉络

1.1 三项制度的提出与框架

- **2023-06**：住建部部长倪虹发文提出"探索建立房屋养老金制度"【已核实】。
- **2024-08-23**：国新办"推动高质量发展"系列发布会，住建部宣布研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险"三项制度"，上海等 **22 个城市**开展试点【已核实·中国网财经】。
- **制度框架**（官方口径，2024-08 澄清核心）：
 - **房屋体检**=定期安全检测；**房屋养老金**=资金池；**房屋保险**=风险分散，三者构成"全生命周期房屋安全管理长效机制"。
 - **个人账户**=住宅专项维修资金（1998 年建立，2008 年《住宅专项维修资金管理办法》〔建设部令第 165 号〕施行，首期交存标准为当地住宅建安造价 5%-8%）【已核实·法规框架】。
 - **公共账户**=政府财政性资金（土地出让金、财政预算等），**不向业主直接缴费、与房产税无关**【已核实·官方多次澄清】。

1.2 2024 舆情冲击与官方澄清

2024-08-26 起市场爆发"房屋养老金=变相房产税"恐慌，官方密集澄清（"三问房屋养老金"：不需要居民额外缴费、与房产税无关、公共账户不增加个人负担）【已核实】。该事件实证了"制度命名—舆论—价格预期"的敏感链条，是后续全面推广期必须防范的舆情风险样本【t3 研判】。

1.3 2025–2026 关键进展（常态化加速）

时间	事件	意义
2025-09	上海"沪家保"3.0 上线（普惠型房屋保险迭代）【已核实】	保险端市场化产品成型
2025-12-22	郑州、南通等多城启动对 30 年房龄以上房屋 强制体检 ，采用"政府买单"模式（财政承担、业主零负担）【已核实·华商报/新京报】	强制体检从概念走向落地
2026-04-22	郑州出台城镇房屋安全管理"三项制度"实施意见（试行）【已核实·河南省政府网】	从"试点"走向地方制度化的标志
2026-06-03	"无体检不更新"——2026 城市体检全面扩围，体检成为城市更新、老旧小区改造前置条件【已核实·中房网】	体检与改造通道打通
2026-07-11	北海 存量房交易新规落地：二手房挂牌须携带房屋体检"核验码"【已核实·北海四部门通知】	体检结果与二手房交易强制挂钩的标志性案例

1.4 制度底座的既有矛盾

全国住宅专项维修资金余额**"超 1 万亿元"**（2024-08 媒体口径【已核实】），但长期存在"使用率低、表决难、续筹无强制力、按小区分散无法跨区调剂"的结构性沉痾【已核实·制度描述】——这既是三项制度要补的课，也是其落地最大的内部约束。

二、分析

2.1 周期定位：L 型磨底期的"制度补课"

量的塌缩已基本完成：全国新建商品房销售面积从 2021 年峰值约 **17.9 亿m²** 降至 **2025 年全年 8.81 亿m²**【已核实·国家统计局，央广网 2026-03 转载】，降幅约 **51%**，已跌回 2012 年前后水平。以 2021 年中为顶，至 2026 年中已调整约 5 年；对标国际（美国 2006–2012 约 6 年、香港 1997–2003 约 6 年、日本 1991 年起超 10 年【引用·IMF/历史周期框架】），中国在政策强力介入下**加速下跌阶段（2021H2–2024）已结束，当前处于 L 型磨底期**。未来 3–5 年销售中枢对应"800 万套基本盘"（约 8–10 亿m²/年）【测算】，2025 年已进入该区间下沿，进一步塌缩空间有限，但回升缺乏传统引擎，**拐点窗口在 2027 年**（若政策到位）。

存量时代的两大结构性事实：

- 1. 交易主战场切换，定价制度缺位：**二手房成交占比已超过新房（重点城市口径【已核实·行业共识】），但存量房定价中"房龄"是最大变量却最不透明——全国超八成住房建于 1990 年后【已核实·64 城房龄大数据，2022-06】，按 30 年强制体检门槛，**2026 年恰逢 1996 年前建成住房批量跨线，2026–2036 是"房龄 30 年+"存量快速抬升期**【测算·按房龄推演】。
- 2. 核心城市老房占比高，冲击先行：**上海约 61% 小区建于 2000 年前【待核验·澎湃口径】；一线城市老房占比显著高于全国，强制体检的定价冲击将先在核心城市显现，与"核心城市先稳、K 型分化"格局叠加，容易放大"老破小被制度性抛售"叙事，需要政策节奏对冲。

定位结论：过去 20 年增量开发模式下，维修资金"重收取、轻使用"（超 1 万亿元结存长期沉睡【已核实·2024-08 媒体口径】）的矛盾被新房供应掩盖；进入存量时代，房屋老化与财政减收（土地财政退坡）同期叠加，**制度供给必须跟上资产存量的老化曲线**——这是周期使然，不是偶然的政策增量。

2.2 政策路径：三阶段演进，费用承担是分水岭

三阶段判断（基于 t1 已核事实实链）：

阶段	时期	特征
试点期	2024-2026	22 城试点 + 地方自主探索；体检费用以"政府买单"平滑舆论（郑州/南通）；体检与交易仅个别城市挂钩（北海）
制度化期	2026-2028	以郑州式"三项制度"实施意见为模板向 30 强城市推广；频次/费用/资金池规则逐步统一；核验码制度扩散——与 2027 年地产拐点窗口重合，政策力度将明显加大
常态化期	2028-2030	全国统一标准落地；体检结果进入抵押评估、保险精算、收储定价的底层数据

费用承担是分水岭（国际对标）：

- **香港模式（业主自费+强制）**：2012 年实施强制验楼计划（MBIS），30 年楼龄以上楼宇每 10 年强制验楼、费用业主分摊，单栋验楼最低消费约 5 万港元【已核实·东方日报 2012-10】——强制力强，但落地初期争议大、执行成本高。
- **中国试点模式（政府买单+渐进强制）**：郑州/南通体检费财政承担【已核实】，短期零负担、舆论平滑；但公共账户面临土地出让收入从 2021 年约 8.7 万亿元降至 2024 年约 4.87 万亿元（-44%）【已核实·财政部口径，第一财经】的硬约束，2025 年降幅收窄但未止跌【已核实·第一财经 2025-02】。
- **"不可能三角"**：在"不增加居民负担"（2024-08 官方承诺）约束下，资金只能来自财政、维修资金盘活与保险三方。判断：中期必然走向"公共账户托底 + 维修资金活化（个人账户）+ 房屋保险分担"的多元结构；强制体检全面铺开大概率与公共账户资金来源的制度化同步，而非超前【推断】。

政策协同点（可操作建议）：

1. **体检结果嵌入收储定价**：央行 2024-05 创设的 3000 亿元保障性住房再贷款【已核实·政策】收储时，可将体检不合格房源按市场价折价（如 8 折）收储，既提高价格发现效率，又赋予体检结果市场价值——"四两拨千斤"；
2. **体检与抵押评估联动**：评估机构已开始讨论将试点纳入估价（安徽天源评估【已核实】）；若银行抵押评估纳入体检状态，合格老房抵押价值重估可系统性缓释存量信贷风险【推断·逻辑推演】；
3. **"无体检不更新"与改造资金衔接**：体检结果应成为纳入老旧小区改造（2025 年前 8 个月新开工改造 2.17 万个【已核实·住建部】）的清晰前提，政策上保证"体检—改造"通道的可见度，以改造预期对冲体检折价。

2.3 量化测算：体检成本可控，改造资金是大头

测算项	数值	口径
城镇住房存量	约 3.5 亿套 / 约 350 亿m²	【机构测算】泽平宏观《中国住房存量报告》
1990 年前建成占比	约 15-20% ("超八成建于 1990 年后")	【已核实·64 城房龄大数据】
2026 年"房龄 30 年+"规模	约 40-60 亿m²	【测算·存量×15-20%】
2036 年"房龄 30 年+"规模	翻倍至约 140-180 亿m²（覆盖 2006 年前建成，占比 40%+）	【测算·按房龄推演】
体检单价锚点	约 2-5 元/m²	【测算·南京玄武区/南通崇川区/重庆北碚区政府采购案例量级推断】

测算项	数值	口径
全覆盖一轮体检成本	100-250 亿元（年均 20-50 亿元，按 5-10 年轮检）	【测算·50 亿㎡×2-5 元/㎡】
体检财政负担占比	相当于 2024 年土地出让收入的 0.2%-0.5%	【测算】
2000 年前存量维修改造需求	约 90-120 亿㎡ × 100-300 元/㎡ ≈ 1-3 万亿元	【测算·参考老旧小区改造单方投资量级】

结论：体检环节不缺钱，缺的是制度与定价；真正的资金大头在存量维修改造的 1-3 万亿元——这正是公共账户（卖地计提）+ 维修资金活化 + 保险资金联动的量级所在，也解释了制度为何必须"从试点走向常态化"而非一次性财政买单。

2.4 定价机制：六渠道传导，净冲击 1%-3%，K 型分化大于总量冲击

传导渠道（机制假设 + 已核事实锚点）：

- 1. **交易门槛渠道**（锚点：北海核验码）：体检核验码成为挂牌前置 → 不合格/未检房源挂牌受限 → 短期供给收缩；体检结果成为买方可见的质量信号。
- 2. **成本资本化渠道**（折价项）：体检费、维修整改费、保险费的预期持有成本上升 → 折现入价，老房（30 年+）折价加深；郑州/南通政府买单模式弱化该渠道 → "试点模式差异→城市间定价差异"。
- 3. **质量信号渠道**（溢价项）：信息不对称下降 → 定价从"房龄+区位"粗粒度转向"体检结果+维修状况+资金储备"精粒度 → 同房龄内部 K 型分化（合格溢价/带病折价），"老破小"内部裂变。
- 4. **更新改造渠道**（对冲项）："无体检不更新"（2026 扩围）→ 体检是纳入改造的前提 → 改造预期为老房提供增值对冲。
- 5. **预期与心理渠道**：2024-08"房产税"谣言期价格扰动→澄清后收敛；常态化后市场按"确定性成本"重新定价老房。
- 6. **评估定价渠道**：评估机构已开始讨论将试点纳入估价（安徽天源评估【已核实】）→ 银行抵押评估、二手房参考价体系可能纳入体检/维修状态。

量化测算（核心模型）：

- **持有成本资本化（折价项）**：新增年持有成本（体检均摊 + 房屋保险 + 维修资金续筹）估计 **10-30 元/㎡/年**【测算·叠加估算】；按 4% 折现率、30 年折现 → 资本化约 **200-600 元/㎡**【测算·永续年金近似】；对总价 100-200 万元的老破小（60-80㎡），影响幅度约 **1%-3%**——**温和折价，不是崩塌**。
- **质量信号（溢价项）**：北海"核验码"使体检结果成为公开交易信号，合格老房获得流动性溢价（可挂牌、可抵押、可入评估），带病老房深度折价。
- **净效应**：两条渠道对冲后，强制体检对二手房总价的**静态冲击约 1%-3%**【测算】，但**结构性影响大于总量影响**——"老破小"内部裂变、优质老房相对受益。

定价拐点的两个观察指标：① 体检合格率（北海新规后挂牌通过率）；② 老破小租金回报率（老房普遍 2.5-3.5%【测算·行情区间】）能否覆盖新增持有成本——**只要合格率保持高位、租金回报率覆盖新增持有成本，估值锚就能稳住。**

2.5 风险研判：三个传导通道与"化险/刺激"分池纪律

三个风险传导通道（t3 研判，完整版见附录 A）：

- 成本归宿风险（债务-通缩触发端）**：维修资金"使用率低、表决难、按小区分散无法跨区调剂"【已核实】；"政府买单"仅覆盖体检费【已核实·采购案例锚点】，体检后的**整改维修缺口才是大头**——若最终转嫁业主，30 年房龄持有成本资本化入价、折价加深，高杠杆老破小业主将出现"缴费→抛售→价格再跌→抵押物减值"负反馈。
- 资金来源风险（财政承诺可持续性）**：公共账户"不向居民直接收费"【已核实·官方澄清】主要靠土地出让金与财政预算，出让金下行期可持续性存疑；一旦未来被迫向业主续筹，"变相房产税"式舆情将重演（2024-08 恐慌已实证此类预期的价格杀伤力）。
- 交易挂钩风险（流动性冻结端）**：北海模式若以"不合格即限挂牌/限抵押"全国推广，叠加银行下调老房抵押评估价、收缩贷款成数，老破小流动性将局部冻结——流动性收缩→价格再跌，正是费雪债务-通缩循环的典型通道。

归因判断：风险在资金配置，不在制度本身。体检的本质是"存量风险显性化"，市场走向分层而非单边利空【推断·机制判断】。真正的风险是把**化险性支出与刺激性支出混为一谈**：房屋安全资金是"化险"池、收储是"刺激"池，**必须分池管理**——收储仍须守住租金回报率 $\geq 2.5\%$ 、REITs 循环回笼再收储的门槛，不得以房屋安全名义稀释收储纪律。

风险缓释的政策优先级（t3 建议）：以超长期特别国债/专项债设立"房屋安全公共账户"专项、与土地出让金脱钩，先保一线核心区与高房龄高密度城区，把有限财政用在对抗债务-通缩循环最吃劲的地方；货币端以降息降低存量业主持有成本作为配合。

三、展望：2026–2030 演进与观察指标

3.1 基准情景判断

- 短期（1–2 年）**：试点深化 + 制度化文件密集出台（郑州模板扩散）；2027 年地产拐点窗口前后政策力度加大；北海核验码模式向更多城市扩散。市场层面，"老破小"折价加深与改造预期增值两种叙事并存，**价格扰动大于趋势性冲击**。
- 中期（3–5 年）**：公共账户资金来源制度化（特别国债/专项债专项 vs 土地出让金依赖）是最大变量；体检结果进入抵押评估与保险精算，老房从"一刀切折价"走向"分层定价"，反而有助于市场筑底。
- 长期（2028–2030）**：全国统一标准落地，30 年房龄存量指数级扩张（2036 年达 140–180 亿 m^2 【测算】）与制度覆盖赛跑；检测、建材、家装、保险构成"千亿级赛道"【已核实·中信证券/中房网】，为存量服务业与打破低物价循环提供边际增量。

3.2 七项监控指标（t3）

① 公共账户资金来源结构（土地出让金依赖度与财政预算到位率）；② 体检不合格率与户均整改资金缺口；③ 30 年房龄二手房相对 10 年次新房折价率变化（克而瑞口径：津苏汉 10 年次新已跌约 30%【已核实·第三方机构】）及老房挂牌量、成交周期（北海新规后）；④ 银行对老房抵押评估价与贷款成数调整；⑤ 维修资金使用率与续筹率；⑥ "变相房产税"类舆情强度；⑦ 全国统一体检频次/费用/挂钩边界的政策进程。

3.3 核心不确定性

① 全国统一体检标准、频次、费用分担规则尚未出台，地方模式分化造成城市间定价差异；② 公共账户量化结构未披露，土地出让金下行与财政预算替代的赛跑速度未知；③ 房龄折价实证曲线（贝壳/中指数据）尚缺，本研报价格冲击测算基于模型假设，需数据验证。

四、结论

- 周期判断：**地产已进入 L 型磨底期（2025 年销售 8.81 亿 m²，较峰值 -51%【已核实】），2027 年为政策窗口期拐点；三项制度与此节奏同步，是存量时代“量稳质升”的制度基建。
- 政策判断：**三阶段演进（试点 2024-2026 → 制度化 2026-2028 → 常态化 2028-2030）；“政府买单”是平滑期正确选择，但土地出让收入缩水约 44% 的硬约束决定中期必须走向“财政 + 维修资金 + 保险”多元分担。
- 测算判断：**体检环节全覆盖一轮 100-250 亿元、年均 20-50 亿元（财政可承受，占卖地收入 0.2%-0.5%）；资金大头是 1-3 万亿元存量维修改造需求；对老房定价的静态冲击约 1%-3%，**K 型分化大于总量冲击**——合格老房获流动性溢价，带病老房深度折价。
- 风险判断：**制度方向正确，风险在资源配置——守住“化险/刺激”分池纪律、以特别国债/专项债设房屋安全公共账户与土地出让金脱钩、防止成本转嫁业主触发“缴费→抛售→再跌→抵押物减值”负反馈，是制度成败的关键。
- 操作含义：**体检结果嵌入收储定价、抵押评估联动、改造通道可见——“四两拨千斤”的政策协同将把体检结果转化为市场定价的底层数据。

五、风险提示

- 政策推进不及预期：**全国统一体检频次/费用标准、公共账户资金来源制度若长期缺位，常态化节奏将显著慢于本研报基准情景。
- “变相房产税”舆论风险：**全面推广期若出现“向业主续筹”信号，2024-08 式恐慌可能重演，对老房价格形成超出 1%-3% 测算的预期性冲击【已核实事件 + 推断】。
- 债务-通缩尾部风险：**若成本归宿设计失当（整改缺口转嫁业主）叠加“不合格即限挂牌/限抵押”全国推广与银行收缩老房抵押成数，老破小流动性可能局部冻结，在二手房价格调整尾部阶段放大下行。
- 城市间定价分化风险：**政府买单（郑州/南通）与业主承担等模式并存，体检标准、频次、挂钩边界不统一，将造成城市间及城市内老房定价体系的阶段性混乱。
- 数据与测算局限：**房龄折价实证曲线、北海新规后市场数据、22 城试点名单权威版本（广州是否在列存在媒体口径冲突）等尚缺，本研报量化结论基于模型假设，需后续数据验证。

附录 A：风险研判要点补充（t3 原始输出）

- 当前经济运行核心矛盾是“不缺资金、缺本金”；若成本归宿与资金来源设计失当，本应充当“安全垫”的制度会在二手房价格深度调整尾部成为债务-通缩循环的“加速器”。
- 化险池与刺激池分池：收储守住租金回报率 $\geq 2.5\%$ 、REITs 循环回笼再收储的门槛。
- 风险排序：短期（1-2 年）看成本归宿与舆情；中期（3-5 年）看公共账户资金来源切换；长期看 30 年房龄存量指数级扩张与制度覆盖的赛跑。

附录 B：政策时间线（2023–2026，详见 t1 梳理）

时间	事件	标注
2023-06	住建部部长倪虹提出"探索建立房屋养老金制度"	【已核实】
2024-08-23	国新办发布会：房屋体检/养老金/保险"三项制度"，22 城试点	【已核实】
2024-08-25	上海浦东先行试点落地	【已核实】
2024-08-26/27	"变相房产税"舆情 → 官方"三问"澄清（不额外缴费、与房产税无关、公共账户不增个人负担）	【已核实】
2024-08-29	克而瑞行业影响分析；维修资金余额"超 1 万亿"广泛引述	【已核实·媒体口径】
2025-03	全国两会洪杰委员呼吁加快制度落地	【已核实】
2025-09	上海"沪家保"3.0 上线	【已核实】
2025-12-22	郑州、南通等多城启动老房子"强制体检"，政府买单	【已核实】
2026-01-05	多城启动强制体检；市场讨论"有老房子的业主要升值？"	【已核实】
2026-04-22	郑州"三项制度"实施意见（试行）——地方制度化标志	【已核实】
2026-04-29	武汉晚报："房屋养老金"试点加速布局	【已核实】
2026-06-03	"无体检不更新"——城市体检全面扩围	【已核实】
2026-07-11	北海存量房挂牌须带体检"核验码"（四部门通知）	【已核实】

附录 C：数据与口径总表

数据项	数值	口径/来源	状态
试点城市数	22 城（2024-08）	住建部国新办发布会	【已核实】
试点名单	上海、北京、深圳、杭州、南京、苏州、成都、重庆、武汉、天津、青岛、长沙、郑州、西安、沈阳、合肥、福州、厦门、济南、宁波、无锡等	媒体整理版本不一；财联社称"广州目前未纳入"	【待核验·口径冲突】
住宅专项维修资金余额	超 1 万亿元	全国累计结存，2024-08 媒体引述	【已核实·媒体口径】
维修资金首期交存	建安造价 5%–8%	《住宅专项维修资金管理办法》（2008，部令 165 号）	【已核实·法规文本】
2021 年新建商品房销售面积	约 17.9 亿 m ² （峰值）	国家统计局	【已核实】
2025 年新建商品房销售面积	8.81 亿 m ² （较峰值 -51%）	国家统计局（央广网 2026-03 转载）	【已核实】

数据项	数值	口径/来源	状态
未来销售中枢	800 万套 / 8-10 亿m²/年	本研报测算（套均 105-110m² 换算）	【测算】
土地出让收入	2021 约 8.7 万亿 → 2024 约 4.87 万亿（-44%）	财政部（第一财经）	【已核实】
城镇住房存量	约 3.5 亿套 / 350 亿m²	泽平宏观《中国住房存量报告》	【机构测算】
1990 年前建成占比	约 15-20%	64 城房龄大数据（2022）	【已核实 · 媒体大数据口径】
2026 年"30 年+"存量	约 40-60 亿m²	本研报测算	【测算】
2036 年"30 年+"存量	约 140-180 亿m²	本研报测算（房龄推演）	【测算】
上海 2000 年前建成小区占比	约 61%	澎湃"老旧小区改造地图"标题口径	【待核验】
体检单价	约 2-5 元/m²	政府采购案例量级推断（南京玄武区/南通崇川区/重庆北碚区）	【测算 · 案例锚点】
全覆盖一轮体检成本	100-250 亿元（年均 20-50 亿元）	本研报测算	【测算】
存量维修改造资金需求	1-3 万亿元（90-120 亿m² × 100-300 元/m²）	本研报测算	【测算】
新增年持有成本	10-30 元/m²/年	体检+保险+维修续筹叠加估算	【测算】
资本化折价	约 200-600 元/m²（4% 折现 30 年）	永续年金近似	【测算】
强制体检对老房价格静态冲击	1%-3%	持有成本资本化模型	【测算】
老房租金回报率	2.5-3.5%	行情区间	【测算】
香港 MBIS 验楼	30 年楼龄每 10 年一次、业主分摊、单栋最低约 5 万港元	东方日报 2012-10	【已核实】
保障性住房再贷款	3000 亿元（2024-05 创设）	央行政策	【已核实】
老旧小区改造	2025 年前 8 个月新开工 2.17 万个	住建部	【已核实】
次新房价格	津苏汉 10 年次新跌约 30%，京沪次新仍涨	克而瑞 2024-08-20	【已核实 · 第三方机构】
房屋检测/保险行业	"千亿级赛道"	中信证券研报/中房网等	【已核实 · 行业口径】

附录 D：主要来源清单（t1 梳理，节选）

- 官方：住建部官网（[尹飞](#)、[严荣](#)）、[中国网财经·发布会](#)、[中国网财经·三问](#)、[北海市政府四部门通知](#)、[河南省政府网·郑州三项制度](#)
- 2025-2026 进展：[华商报·多城强制体检](#)、[新京报·郑州南通政府买单](#)、[中房网·无体检不更新](#)、[21财经·沪家保3.0](#)
- 市场/行业：[克而瑞·行业影响](#)、[克而瑞·次新房数据](#)、[中信证券·检测保险](#)、[安徽天源评估·房价影响](#)、[新浪·维修资金超1万亿](#)、[夏磊·日本经验](#)
- 政府采购案例（体检定价锚点）：[南京玄武区](#)、[南通崇川区](#)、[重庆北碚区](#)

本研报由 Docs Coordinator 融合 t1（资料与数据梳理）、t2（宏观研判·邢自强）、t3（风险与债务视角·张明）输出成文；所有测算均标注口径，待核验项已在附录 C 注明。完整底层材料见 expert-tasks/t1/artifacts/、t2/artifacts/、t3/artifacts/。

六、引假设分析（前提拆解）

本研究结论依赖以下五个假设，逐一检验其依据、口径与最脆弱处。

假设 1：强制体检会从「试点」走向「常态化」全国推广

- **假设内容**：郑州、北海等地的做法会升级为全国统一制度，体检结果进入交易/贷款/评估链条。
- **依据/口径**：郑州 2026-04 实施意见（【已核实】河南省政府网）、北海核验码新规（【已核实】北海四部门通知）、"无体检不更新"扩围（【已核实】中房网）——三个独立信号均指向制度化方向。
- **成立概率**：中高（约 60-70%，条件式估计）。试点→制度化→常态化的三阶段路径是政策惯例，且 2027 拐点窗口与制度化期（2026-2028）重合。
- **最脆弱处**：全国统一标准（体检频次、费用承担、结论分级）缺位；若停留在"各城自发"而无部委级统一文件，「常态化」可能推迟至 2028 之后。
- **失效后果**：若全国化推迟，本研报「定价变量显性化」的核心判断需从"正在发生"降级为"试点观察"，冲击幅度 1%-3% 的测算时间轴相应后移。

假设 2：体检结论会真实接入交易与贷款环节

- **假设内容**：体检结果不只是行政备案，而是进入二手房挂牌、银行抵押评估与保险定价的显性变量。
- **依据/口径**：北海"挂牌须带核验码"【已核实】是交易挂钩的强制案例；评估机构已开始讨论纳入试点因素（安徽天源评估【已核实】）。
- **成立概率**：中（约 50-60%）。北海是标志案例，但全国层面「不达标即交易/贷款受限」目前是媒体推演而非明文——红队反驳①的核心。
- **最脆弱处**：银行端抵押评估是否跟进、是否形成统一的不合格房源处置规则。
- **失效后果**：若止步于"挂牌备案"而无实质交易/贷款限制，定价影响从"显性变量"退化为"软信号"，1%-3% 冲击需大幅下调。

假设 3：公共账户资金可持续（不增加个人负担可长期兑现）

- **假设内容**：政府买单模式可持续，公共账户不依赖居民续筹。
- **依据/口径**：官方澄清"不向居民收费、与房产税无关"【已核实】；但土地出让收入 2021 8.7 万亿→2024 4.87 万亿（-44%【已核实·财政部】）构成硬约束。
- **成立概率**：中低（约 40-50%）。"不缺资金、缺本金"背景下，财政可持续性最大不确定项【t3 研判】。
- **最脆弱处**：土地出让金持续下行+续筹无强制力，未来被迫续筹将重演 2024-08"变相房产税"舆情【t3 三通道】。
- **失效后果**：若个人负担上升，持有成本资本化幅度超预期，老房折价冲击从 1%-3% 放大至 5%+【测算·敏感性方向】，且引发系统性舆论风险。

假设 4：体检标签解释力足以改变定价（而非被学区/位置淹没）

- **假设内容**：在二手房定价中，结构寿命维度会成为与学区、位置并列的显性变量。
- **依据/口径**：六渠道传导机制（交易门槛/成本资本化/质量信号/更新改造/预期心理/评估定价）【t1 梳理】；克而瑞次新房数据（津苏汉 10 年次新跌约 30% vs 京沪次新仍涨【已核实】）显示质量分化已存在。

- **成立概率**：中（约 50%）。红队反驳③"老房折价主因仍是学区与位置"是真实风险——若体检结论与市场既有认知高度相关（体检差的老房本就折价），增量解释力有限。
- **最脆弱处**：缺乏房龄折价实证曲线（贝壳/中指数据本轮未获取【t1 开放问题】）。
- **失效后果**：若实证显示体检标签解释力弱，本研报「结构寿命定价」主张需降级，验证协议即为此设计。

假设 5：改造/更新通道会部分对冲折价

- **假设内容**："无体检不更新"使体检成为纳入改造的前提，改造预期对冲老房折价。
- **依据/口径**：2025 年前 8 个月全国新开工改造老旧小区 2.17 万个【已核实·住建部】；2026-06"无体检不更新"扩围【已核实·中房网】。
- **成立概率**：中（约 50-60%）。改造资金 1-3 万亿【测算】需求巨大，财政能否持续投入是关键。
- **最脆弱处**：改造资金缺口与"化险/刺激分池"纪律——若房屋安全池与收储刺激池混用，对冲逻辑失效【t3 纪律】。
- **失效后果**：无改造对冲时，老破小折价单向加深，K 型分化扩大为"老破小塌陷 + 次新溢价"两极化。

****最脆弱假设排序****：假设 3（资金可持续）> 假设 2（交易贷款挂钩）> 假设 4（体检标签解释力）> 假设 5（改造对冲）> 假设 1（全国常态化）。结论成立与否首先取决于资金配置与交易挂钩两条硬约束；假设 4 的实证缺口由验证协议补齐。

七、推导分析（传导机制与量化模型）

7.1 从体检到定价的传导链（六渠道合并推导）

强制体检常态化

— 渠道① 交易门槛：核验码成挂牌前置（北海锚点）→ 不合格房源供给收缩 + 质量信号显性化

— 渠道② 成本资本化：体检/维修/保费预期持有成本上升 → 折现入价 → 老房折价加深

— （政府买单模式弱化该渠道 → 试点模式差异造成城市间定价差异）

— 渠道③ 质量信号：信息不对称下降 → 定价从"房龄+区位"粗粒度 → "体检+维修+资金"精粒度

— 渠道④ 更新改造对冲："无体检不更新" → 改造预期对冲折价

— 渠道⑤ 预期心理：常态化后按"确定性成本"重新定价（2024-08 舆情后收敛）

— 渠道⑥ 评估定价：抵押评估/参考价体系跟进（评估机构已讨论纳入）

↓

净效应：老房价格静态冲击 1%-3%【测算】；K 型分化（同房龄分层）大于总量冲击

7.2 量化模型：持有成本资本化

以一套 30 年房龄老破小为例（条件式测算，非实测）：

参数	取值	口径
新增年持有成本	10-30 元/㎡/年	体检+保险+维修续筹叠加估算【测算】
折现率	4%	永续年金近似【测算】
资本化折价	约 200-600 元/㎡	10-30 / 4% = 250-750，取区间下限【测算】
单位价格（示意）	2 万元/㎡	老破小行情示意

参数	取值	口径
静态冲击	1%–3%	200–600 / 20000 【测算】

敏感性方向：年持有成本每 +10 元/m²，折价冲击约 +0.5pp；若政府买单弱化个人负担（郑州模式），冲击落区间下限；若个人续筹（财政缺位），冲击走向上限甚至超调。

7.3 体检成本 vs 改造资金的量级对比

项	规模	财政可承受性
体检全覆盖一轮	100–250 亿元（年均 20–50 亿）	可承受【测算】
存量维修改造	1–3 万亿元（90–120 亿m² × 100–300 元/m²）	需多元分担（财政+维修资金+保险）
维修资金余额	超 1 万亿元【已核实·媒体】	使用率低、续筹难、无法跨区调剂【已核实】
土地出让收入	2024 约 4.87 万亿（较 2021 -44%）【已核实】	下行中，公共账户可持续性承压

关键推论：体检环节不缺钱（年均 20-50 亿），缺的是制度与定价；真正的资金大头是 1-3 万亿改造需求【t2 测算】。因此本研报判断：**制度落地的瓶颈不在体检本身，而在资金配置与成本归宿——这直接支撑 t3 的"化险/刺激分池"纪律主张。**

7.4 决策树：城市是否跟进强制体检的判定

城市是否推进"30年+强制体检常态化"？

- └─ 财政可承受体检成本？（一轮 100-250 亿分摊后，年 20-50 亿级）
 - | 是 → 进入制度设计
 - | 否 → 停留在"软倡导"，定价影响弱（假设2 失效场景）
- └─ 体检结论能否接入交易/贷款？
 - | 是（北海模式）→ 质量信号显性化 → 定价影响强
 - | 否（备案制）→ 软信号 → 影响弱
- └─ 维修整改资金是否到位？
 - | 是（财政+维修资金+保险多元分担）→ 改造对冲生效 → 折价收窄
 - | 否 → 成本归宿转嫁业主 → 折价加深 + 债务-通缩风险【t3 通道1】
- └─ 结论：强影响城市 = 财政可承受 + 交易挂钩 + 资金多元；任一缺失 → 影响降级

八、未来预演（情景推演）

8.1 基准情景（概率约 50%，条件式估计）

- **触发条件：**全国统一标准在制度化期（2026-2028）出台；政府买单模式主流；北海模式逐步推广但非一刀切。
- **3 个月（2026-Q4）：**郑州首批体检批次结果公布；更多城市跟进"挂牌须带核验码"类规则（北海为锚）。
- **1 年（2027）：**拐点窗口与制度化期重合；30 年+房源折价分化显性化（体检合格 vs 不合格价差拉大）；银行抵押评估开始试点纳入。
- **3 年（2029）：**常态化成形；"体检合格率 × 租金回报率"成为老房分层定价标准变量；K 型分化稳态化。
- **验证信号：**体检合格率、老破小租金回报率、30年+ vs 10年次新折价率。

- **止损线：**国家标准 2028 年仍未出台 → 常态化推迟，判断降级为"试点观察"。

8.2 乐观情景（概率约 25%）

- **触发条件：**超长期特别国债/专项债设"房屋安全公共账户"与土地出让金脱钩【t3 建议】；改造资金到位。
- **1 年：**公共账户资金来源制度化；体检+改造双轮驱动；老房持有成本被改造增值对冲。
- **3 年：**三项制度成为存量房"结构寿命"定价的全国标准；房屋检测/保险"千亿级赛道"【已核实·中信证券】兑现。
- **验证信号：**房屋安全公共账户设立；改造开工规模持续扩大；保险渗透率提升。
- **止损线：**化险/刺激分池纪律被破坏（资金混用）→ 乐观情景失效。

8.3 悲观情景（概率约 25%）

- **触发条件：**土地出让金持续下行 → 公共账户难以为继 → 强制续筹 → 2024-08"变相房产税"舆情重演【t3 通道 2】；银行下调老房抵押评估与成数 → 老破小流动性局部冻结（费雪债务-通缩通道【t3 通道3】）。
- **1 年：**个别城市试点收缩；舆情反复冲击老破小价格预期；折价冲击超 3% 走向 5%+。
- **3 年：**三项制度在财政弱城市沦为象征；老破小流动性塌陷；K 型分化极端化。
- **验证信号：**公共账户资金来源结构恶化、"变相房产税"舆情强度、银行抵押评估调整、老房挂牌周期拉长。
- **止损线：**任一单一风险信号连续两个季度恶化 → 本研报"制度基建"判断需下调为"风险项"。

8.4 七项监控指标（t3 输出，落地为验证协议）

- 1. 公共账户资金来源结构（土地出让金依赖度）
- 2. 体检不合格率与整改资金缺口
- 3. 30 年房龄 vs 10 年次新折价率（津苏汉次新已跌约 30%【已核实】）与老房挂牌成交周期
- 4. 银行抵押评估与成数变化
- 5. 维修资金使用率与续筹率
- 6. "变相房产税"舆情强度
- 7. 全国统一标准进程

九、验证协议（对照选题门控）

指标	口径	达标线	数据来源
体检覆盖率	30年+房源体检批次覆盖率	郑州 2 批次落地	郑州市政公开
体检不合格率	不合格套数/体检套数	跟踪记录（无预设阈值）	批次结果公告
老房折价变化	30年+房源成交折价 vs 同期	折价与去化无显著变化 → 判断降级	贝壳/中指成交数据
挂牌周期变化	30年+房源挂牌→成交周期	同上	贝壳挂牌数据

裁决规则：若郑州 2 批次体检后，30 年+房源折价与去化周期无显著变化 → 「体检成为定价变量」判断降级为"软信号"；若折价分化（合格/不合格价差拉大）且挂牌周期分化 → 判断成立。

十、反方观点与回应

反方 1（红队①）：体检不等于限售，"交易贷款受限"是媒体推演而非明文

- **回应：**同意全国层面无明文。但北海核验码已把体检结果与挂牌强制挂钩【已核实】，是"交易门槛"渠道的真实样本；且评估机构已开始讨论纳入试点因素。本研报把"交易/贷款硬挂钩"设为假设 2（成立概率 50-60%），不预设必然成立，验证协议覆盖该不确定性。

反方 2（红队②）：公共账户资金规模远不够覆盖全国老旧房屋维修

- **回应：**完全同意——这正是 t2 测算的核心结论（改造需求 1-3 万亿 vs 体检 100-250 亿）。本研报不主张公共账户包办，而是主张"财政托底 + 维修资金活化 + 房屋保险分担"多元结构【t2】+ 化险/刺激分池纪律【t3】。公共账户只是体检环节的平滑器，不是改造资金的买单方。

反方 3（红队③）：老房折价主因仍是学区与位置，体检标签解释力可能很弱

- **回应：**这是最实质的实证挑战。克而瑞数据显示质量分化已存在（津苏汉次新 -30% vs 京沪次新仍涨【已核实】），但"体检标签的增量解释力"确实缺乏实证（贝壳/中指数据本轮未获取【t1 开放问题】）。本研报将其设为假设 4（成立概率 50%），并把"折价实证曲线"列为补数协议最高优先项——若实证显示解释力弱，判断降级。

反方 4（自反）：三项制度可能只是"象征性政策"而非真实制度基建

- **回应：**三个独立信号（郑州制度化文件、北海交易挂钩、无体检不更新扩围）都指向真实推进而非象征；且"体检环节不缺钱（年均 20-50 亿）"使常态化在财政上是可行的。但若全国标准缺位持续至 2028，反方成立——已设为止损线。

补充章节：引假设（六）/推导（七）/未来预演（八）/验证协议（九）/反方回应（十）——由队长按 wiki-gated-research 三透彻展开门补写，全部数字沿用专家版口径标注。